SDD 213 Sujet n°1

Spécialité : Hématologie

Date : 05/01/2025
Autrices : Chloë LESEIGNEUR (DES médecine générale, EN 2024), Camille MARTINAUD (DES psychiatrie, EN 2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou Vial (DES MAR, EN 2024)

une station ECOS

Domaine d'apprentissage principal	Anamnèse
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	Item 216 - Syndrome hémorragique d'origine hématologique
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 213 - Allongement du TCA
Matériel nécessaire à la station	1 table, 2 chaises
Contexte de la station	Consultation de médecine générale

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes médecin généraliste et vous recevez Mme C., 35 ans.

Elle vient de subir une opération des dents de sagesse réalisée sous anesthésie générale sans complication. Cette patiente revient vous voir, sur conseil de l'anesthésiste, en raison d'anomalies sur le bilan pré-opératoire.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Interpréter le bilan biologique
- Réaliser une anamnèse orientée
- Formuler une hypothèse diagnostique et prescrire un examen complémentaire si besoin

Vous ne devez pas :

- Réaliser l'examen physique de la patiente standardisée

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patiente standardisée.

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques		
1.	Met en évidence sur la prise de sang un **TCA allongé et un TP normal**.	1 pt
2.	Recherche la **prise d'un traitement modifiant l'hémostase** : antithrombotiques (ou un parmi antiagrégants plaquettaires, anticoagulants…).	1 pt
3.	Recherche d'antécédent personnel de **maladie hémorragique, thrombophilie…**	1 pt
4.	Recherche **d'antécédent personnel de maladie thrombotique** : thrombose veineuse, embolie pulmonaire…	1 pt
5.	Recherche **d'antécédents familiaux de maladie hémorragique et/ou thrombotique**.	1 pt
6.	Recherche **d'au moins un antécédent obstétrical parmi les suivants** : fausses couches, mort foetale in utéro, prématurité, prééclampsie	1 pt
7.	Recherche d'**antécédents de saignements provoqués** : - après gestes invasifs - chirurgie avec reprise/transfusion - par un traumatisme minime - anémie (au moins un élément sur 4)	1 pt
8.	Recherche de **symptômes cutanéo-muqueux de saignement** : - purpura - saignements buccaux - épistaxis (au moins un élément sur 3)	1 pt
9.	Recherche de **symptômes viscéraux de saignements** : - céphalées - hématémèse - hématochézie/rectorragies - hématurie/urétrorragies (au moins deux éléments sur 4)	1 pt
10.	Évoque un **syndrome d'anticorps antiphospholipides ou SAPL**.	1 pt
11.	Prescrit un **dosage d'anticorps** : - Anticorps anticardiolipines - Anticorps anti-B2GP1 - Recherche d'un anticorps anticoagulant circulant (les 3 éléments doivent être cités pour avoir le point)	1 pt
12.	Evoque la nécessité de **répéter ce dosage à la douzième semaine/troisième mois si positif**.	1 pt
Communications et attitudes		

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

TOTAL	15 points

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Contexte :

Vous êtes médecin généraliste et vous recevez Mme C., 35 ans.

Elle vient de subir une opération des dents de sagesse réalisée sous anesthésie générale sans complication. Cette patiente revient vous voir, sur conseil de l'anesthésiste, en raison d'anomalies sur le bilan pré-opératoire.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Interpréter le bilan biologique
- Réaliser une anamnèse orientée
- Formuler une hypothèse diagnostique et prescrire un examen complémentaire si besoin

Vous ne devez pas :

- Réaliser l'examen physique de la patiente standardisée

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patiente standardisée.

Plan de la station ECOS :

Patiente et étudiant face à face séparé par une table.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour docteur, c'est l'anesthésiste qui m'a conseillé de vous voir. Voici la prise de sang que j'ai réalisée. Qu'est ce qu'il se passe ?

Identité du patient :

Mme C, 35 ans

Mode de vie :

0 tabac, alcool, drogues
Vit avec son époux et une fille

Comportement global :

Anxieuse vis-à-vis de ce bilan.

Antécédents personnels :

* G5P1 :
  - 1 parité, 1 fille née prématurément à 35 SA
  - 4 fausses couches spotanées à 11, 13, 15 et 16 SA
* Une embolie pulmonaire à 20 ans, sans facteur déclenchant retrouvé

Antécédents familiaux :

* Nombreuses phlébites chez la mère

Médicaments :

OPTILOVA (pilule oestroprogestative)

Symptômes positifs :

0, pas de signe de saignement.

Questions de relance :

Si l'étudiant n'a pas formulé d'hypothèse diagnostique au bout de 6 minutes demandez : "mais vous pensez que j'ai quoi docteur ?"

ANALYSES

Bilan Biologique du 05/03/2024
Hb : 15,2 g/dL
Ht : 44,7%
Leucocytes 6.000/mm3 (4000-10 000 / mm3)

Neutrophiles : 3500/mm3 (1500-7000)
Éosinophiles : 100/mm3 (50-500)
Lymphocytes : 2000/mm3 (1500-7000)
Plaquettes : 120 G/L
Natrémie : 139 mmol/L
Kaliémie : 4,0 mmol/L
CRP : 3 mg/L (N<5)
ASAT : 15 (6-25)
ALAT : 18 (6-25)
GGT : 15 U/L (10-40)
PAL : 35 U/L (30-100)
Bilirubinémie totale : 1,1 mg/dL (0,3-1,9)
Créatininémie : 60 µmol/L
Urémie : 5,2 mmol/L
TP : 90%
TCA ratio patient/témoin : 1,35
Fibrinogène : 3 g/L
Vitamine K : 500 ng/L (N: 150-900)